

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

ANEXO III
INFORME DE RESULTADOS, GRÁFICOS Y ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO

Empresa: ECOPARKMINING S.A.

Período evaluado: 2026

Fecha de emisión: Junio

Total de trabajadores: 33

Cobertura: 100 %

Resumen de exámenes realizados

Tipo de examen	Número
Examen físico	33
Laboratorio	30
Radiografía	30
Espirometría	29
Audiometría	29

Clasificación de aptitud laboral

Tipo de Aptitud	Número	Porcentaje
Apto	27	82%
Apto en observación	2	6%
Apto con limitaciones	4	12%
No Apto	0	0%

CUADRO I

DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD SEGÚN PUESTO DE TRABAJO

[illegible]

	P-SG-SSO-002																								
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES																								

PROFESIONALES CON TITULO DE CUARTO NIVEL	1																								
PROFESIONALES CON TITULO DE TERCER NIVEL		1																							
PUBLICISTA	1									1															
SUPERVISOR / AFINES												1													

Los exámenes médicos ocupacionales se realizaron con el propósito de identificar y monitorear los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus labores. Este proceso permite evaluar el estado de salud del personal y establecer medidas preventivas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la empresa **ECOPARKMINING S.A.**, se llevaron a cabo valoraciones médicas a **33 trabajadores**, los cuales representan el **100%** del personal evaluado para este proceso.

El cuadro anterior presenta la distribución de los PUESTOS DE TRABAJO frente a las MORBILIDADES identificadas en los siguientes componentes de la evaluación médica:

- Examen físico
- Exámenes de laboratorio
- Radiografías
- Espirometrías
- Audiometrías

Confidencialidad de la Historia Clínica Ocupacional

La Historia Clínica Ocupacional y los documentos derivados de las evaluaciones médicas ocupacionales son de carácter confidencial y están amparados por el principio de **reserva profesional**. Por lo tanto, su divulgación solo será posible en los siguientes casos:

- Por orden expresa de una autoridad nacional competente.
- Con autorización escrita del trabajador, cuando se requiera con fines estrictamente médicos.
- A solicitud del médico o del prestador de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la realización de evaluaciones médicas, con el consentimiento previo del trabajador, para efectos de seguimiento y análisis.
- Por parte de la entidad o persona autorizada para determinar el origen o calificar la pérdida de capacidad laboral, también con el consentimiento del trabajador.

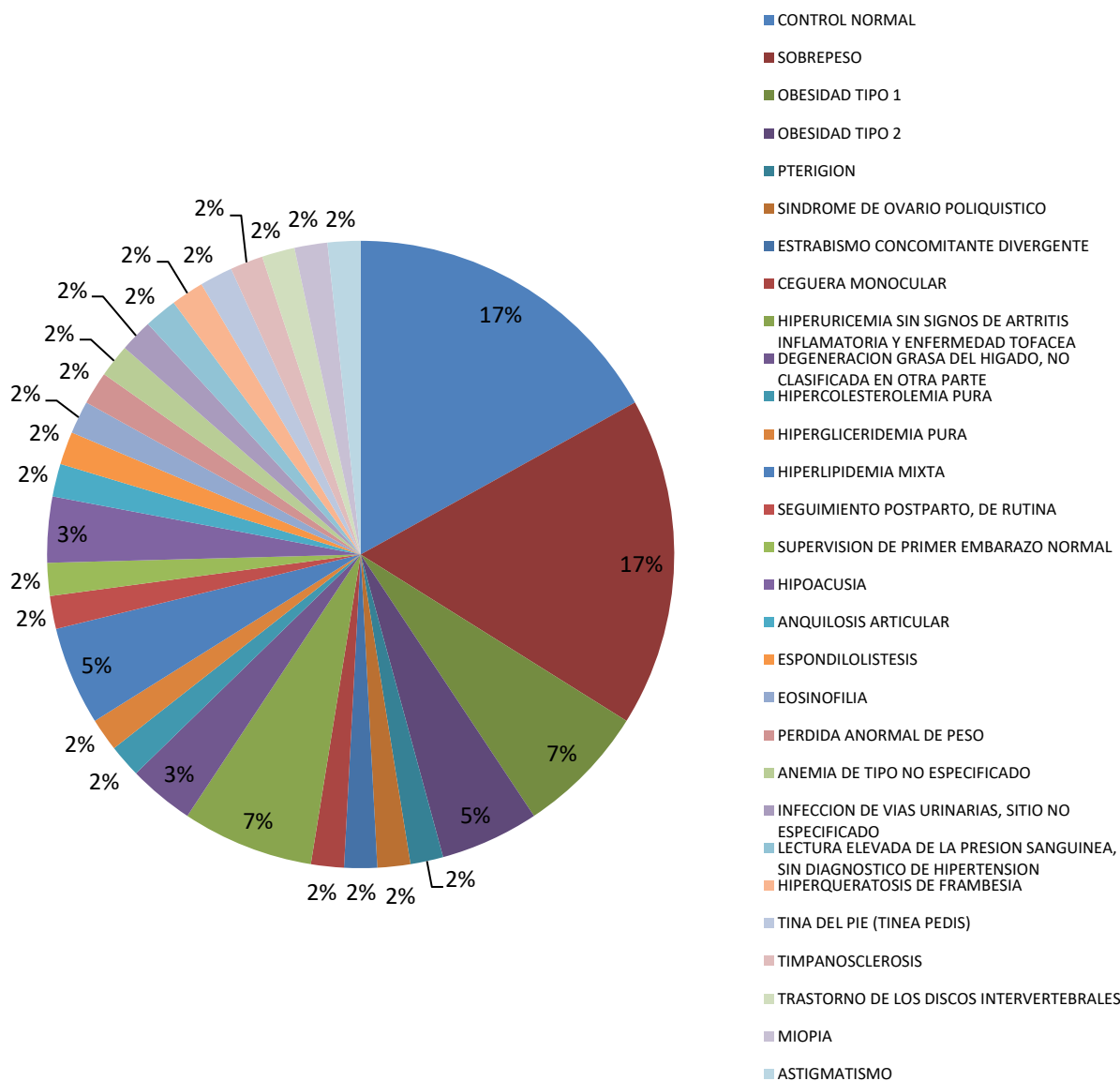
CUADRO II

DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD EN LOS TRABAJADORES

CONTROL NORMAL	10
SOBREPESO	10
OBESIDAD TIPO 1	4
OBESIDAD TIPO 2	3
PTERIGION	1
SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	1
ESTRABISMO CONCOMITANTE DIVERGENTE	1
CEGUERA MONOCULAR	1
HIPERURICEMIA SIN SIGNOS DE ARTRITIS INFLAMATORIA Y ENFERMEDAD TOFACEA	4
DEGENERACION GRASA DEL HIGADO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	2
HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	1
HIPERGLICERIDEMIA PURA	1
HIPERLIPIDEMIA MIXTA	3
SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	1
SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	1
HIPOACUSIA	2
ANQUILOSIS ARTICULAR	1
ESPONDILOLISTESIS	1
EOSINOFILIA	1
PERDIDA ANORMAL DE PESO	1
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1
LECTURA ELEVADA DE LA PRESION SANGUINEA, SIN DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION	1
HIPERQUERATOSIS DE FRAMBESIA	1
TINA DEL PIE (TINEA PEDIS)	1
TIMPANOSCLEROSIS	1
TRASTORNO DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	1
MIOPIA	1
ASTIGMATISMO	1

GRÁFICO I

DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD EN LOS TRABAJADORES



ANÁLISIS:

En el gráfico se presenta la relación entre el porcentaje de trabajadores y las enfermedades diagnosticadas en la empresa **ECOPARKMINING S.A.**

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

De un total de **33 trabajadores evaluados**, se identificaron **59 diagnósticos**, lo que evidencia que varios trabajadores presentan **más de una morbilidad**. En algunos casos, se registraron hasta dos, tres condiciones de salud por persona.

El hallazgo más frecuente fue **control normal**, con **10 registros**, que representa el **16,9% del total de diagnósticos** y equivale al **30,3% de la población evaluada**. Dentro de las morbilidades identificadas predominan las alteraciones nutricionales y metabólicas, destacándose **sobrepeso con 10 casos (16,9%)**, **obesidad tipo I con 4 casos (6,8%)**, **obesidad tipo II con 3 casos (5,1%)**, **hiperuricemia con 4 casos (6,8%)**, **hiperlipidemia mixta con 3 casos (5,1%)**, **degeneración grasa del hígado con 2 casos (3,4%)** e **hipoacusia con 2 casos (3,4%)**.

Adicionalmente, se registraron diagnósticos aislados con **1 caso cada uno (1,7%)**, entre ellos: pterigión, síndrome de ovario poliquístico, estrabismo concomitante divergente, ceguera monocular, hipercolesterolemia pura, hipergliceridemia pura, seguimiento postparto de rutina, supervisión de primer embarazo normal, anquilosis articular, espondilolistesis, eosinofilia, pérdida anormal de peso, anemia no especificada, infección de vías urinarias, lectura elevada de presión sanguínea sin diagnóstico de hipertensión, hiperqueratosis de frambesia, tiña del pie, timpanosclerosis, trastorno de discos intervertebrales, miopía y astigmatismo.

Las morbilidades identificadas no necesariamente tienen origen ocupacional; sin embargo, su identificación permite orientar acciones preventivas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En general, el perfil epidemiológico evidencia predominio de factores de riesgo metabólico y nutricional, por lo que se recomienda fortalecer las actividades de promoción de estilos de vida saludables, control de peso, educación nutricional, actividad física, vigilancia cardiovascular y seguimiento médico ocupacional individualizado.

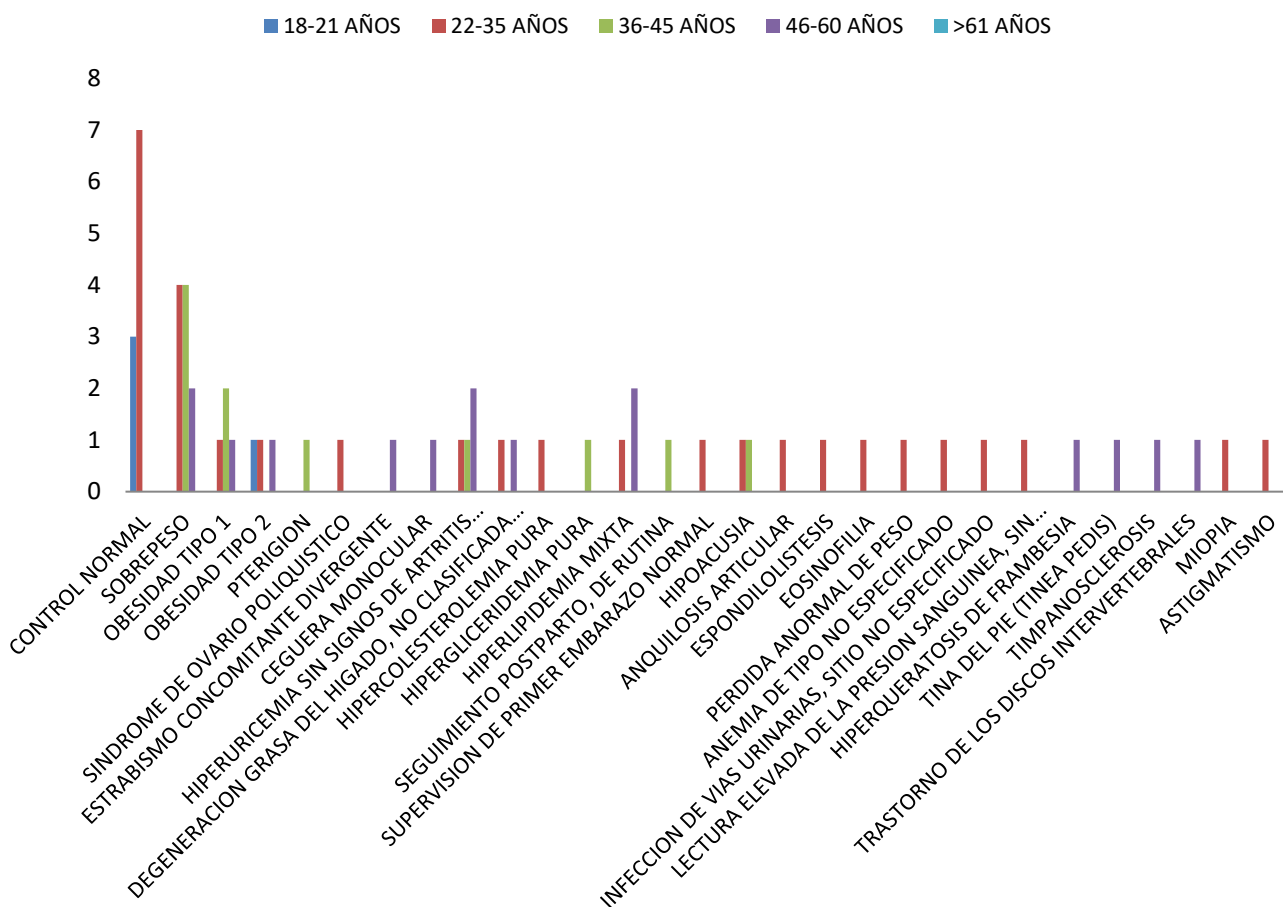
CUADRO III

MORBILIDAD POR GRUPO ETARIO

	CONTROL NORMAL																			
	SOBREPESO																			
	OBESIDAD TIPO 1																			
	OBESIDAD TIPO 2																			
	PTERIGION																			
	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO																			
	ESTRABISMO CONCOMITANTE DIVERGENTE																			
	CEGUERA MONOCULAR																			
	HIPERURICEMIA SIN SIGNOS DE ARTRITIS INFLAMATORIA Y ENFERMEDAD TOFACEA																			
	DEGENERACION GRASA DEL HIGADO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE																			
	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA																			
	HIPERGLICERIDEMIA PURA																			
	HIPERLIPIDEMIA MIXTA																			
	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA																			
	SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO NORMAL																			
	HIPOACUSIA																			
	ANQUILOSIAS ARTICULAR																			
	ESPONDILOLISTESIS																			
	EOSINOFILIA																			
	PERDIDA ANORMAL DE PESO																			
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO																				
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO																				
LECTURA ELEVADA DE LA PRESION SANGUINEA, SIN DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION																				
HIPERQUERATOSIS DE FRAMBESIA																				
TINA DEL PIE (TINEA PEDIS)																				
TIMPANOSCLEROSIS																				
TRASTORNO DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES																				
MIOPIA																				
ASTIGMATISMO																				
18-21 AÑOS	3			1																
22-35 AÑOS	7	4	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1		1
36-45 AÑOS		4	2		1				1		1									
46-60 AÑOS		2	1	1			1	1	2	1			2					1	1	
>61 AÑOS																				

GRÁFICO II

MORBILIDAD POR GRUPO ETARIO



ANÁLISIS:

La distribución de los diagnósticos por edad evidencia que el grupo de 22 a 35 años concentra la mayor cantidad de hallazgos médicos, incluyendo alteraciones nutricionales, metabólicas, musculoesqueléticas, oftalmológicas, ginecológicas y hematológicas. En este grupo se identificaron 7 trabajadores con control normal, así como casos de sobrepeso (4), obesidad tipo I (1), obesidad tipo II (1), hiperuricemia (1), degeneración grasa del hígado (1), hipercolesterolemia (1), hiperlipidemia mixta

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

(1), hipoacusia (1), anquilosis articular (1), espondilolistesis (1), eosinofilia (1), pérdida anormal de peso (1), anemia (1), infección de vías urinarias (1), presión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión (1), miopía (1) y astigmatismo (1), además de casos de síndrome de ovario poliquístico y supervisión de embarazo normal.

El grupo de 36 a 45 años presentó principalmente patologías relacionadas con factores de riesgo cardiovascular y metabólico, destacándose sobrepeso (4 casos), obesidad tipo I (2 casos), hiperuricemia (1 caso), hipercolesterolemia pura (1 caso), hiperlipidemia mixta (1 caso), pterigión (1 caso) e hipoacusia (1 caso).

En el grupo de 46 a 60 años se observó una mayor carga de enfermedades crónicas y degenerativas, predominando sobrepeso (2 casos), obesidad tipo I (1 caso), obesidad tipo II (1 caso), hiperuricemia (2 casos), degeneración grasa del hígado (1 caso), hiperlipidemia mixta (2 casos), ceguera monocular (1 caso), estrabismo concomitante divergente (1 caso), trastornos de los discos intervertebrales (1 caso), timpanosclerosis (1 caso), tiña del pie (1 caso) e hiperqueratosis (1 caso).

Por su parte, el grupo de 18 a 21 años presentó el mejor perfil de salud, con 3 trabajadores en control normal y únicamente 1 caso de obesidad tipo II, mientras que no se registraron trabajadores mayores de 61 años.

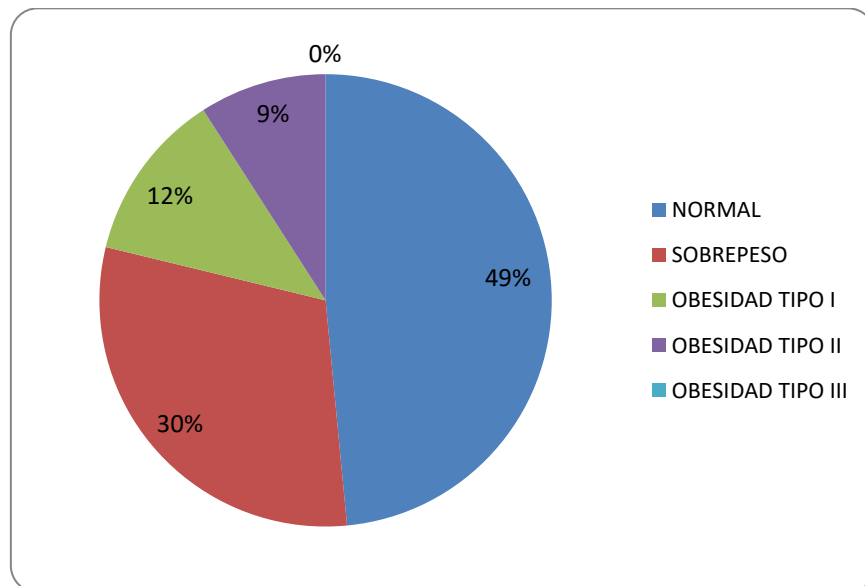
En términos generales, los resultados muestran que las alteraciones metabólicas y nutricionales (sobrepeso, obesidad, dislipidemias e hiperuricemia) se concentran principalmente entre los 22 y 60 años, constituyéndose en los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y crónicas. Por ello, se recomienda fortalecer los programas de promoción de hábitos saludables, actividad física, educación nutricional y vigilancia periódica de factores de riesgo metabólico, especialmente en los grupos etarios económicamente activos.

CUADRO IV

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

CLASIFICACIÓN	PESO	IMC TRABAJADORES
NORMAL	18.5-24.99	16
SOBREPESO	25-29.9	10
OBESIDAD TIPO I	30-34.9	4
OBESIDAD TIPO II	35-39.9	3
OBESIDAD TIPO III	>40	0
	TOTAL	33

GRÁFICO III



Análisis:

De un total de 33 trabajadores evaluados, se identificó que 16 trabajadores (48,5%) presentan un IMC dentro de parámetros normales, mientras que 17 trabajadores

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

(51,5%) presentan algún grado de exceso de peso. Dentro de este grupo, 10 trabajadores (30,3%) presentan sobrepeso, 4 trabajadores (12,1%) obesidad tipo I y 3 trabajadores (9,1%) obesidad tipo II. No se registraron casos de obesidad tipo III.

Los resultados evidencian que más de la mitad de la población evaluada presenta alteraciones en su estado nutricional asociadas al exceso de peso, situación que constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, osteomusculares y endocrinas. Aunque cerca de la mitad de los trabajadores mantiene un peso adecuado, la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad resalta la necesidad de fortalecer programas de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada, actividad física regular y seguimiento médico periódico.

Se recomienda implementar estrategias de vigilancia nutricional y control de factores de riesgo cardiovascular, con énfasis en los trabajadores que presentan sobrepeso u obesidad, a fin de prevenir la progresión de estas condiciones y promover una mejor calidad de vida y desempeño laboral.

Acciones recomendadas

Estrategias por eje de intervención

1. Promoción de la salud nutricional y prevención del sobrepeso/obesidad

- Implementar un programa de alimentación saludable en el entorno laboral, que incluya:
 - Charlas nutricionales periódicas.
 - Evaluaciones de composición corporal (IMC, circunferencia abdominal).
- Fomentar el consumo de alimentos saludables (frutas, verduras, alimentos bajos en grasa y sal).

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

- Reducir el consumo de bebidas azucaradas y snacks ultraprocesados, promoviendo el acceso a agua potable y opciones más saludables.

2. Estimulación de la actividad física

- Pausas activas diarias (5–10 minutos) durante la jornada laboral, dirigidas o mediante videos.
- Promover caminatas grupales, retos saludables o torneos deportivos internos.
- Fomentar el uso de escaleras y caminar en vez de usar vehículos para trayectos cortos.

3. Vigilancia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)

- Monitoreo regular del perfil lipídico, glucosa, presión arterial y peso, al menos una vez al año.
- Establecer una ruta de derivación médica temprana para casos detectados con dislipidemia, hipertensión o diabetes.
- Capacitar al personal sobre signos de alerta y autocuidado para enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

4. Prevención de enfermedades infecciosas y digestivas

- Campañas sobre higiene de manos.
- Monitoreo y control de parasitismo intestinal (por ejemplo, amebiasis), incluyendo tratamiento antiparasitario preventivo cuando esté indicado.
- Reforzar las condiciones de higiene en baños y áreas comunes.

5. Salud visual, auditiva y postural

- Campañas de detección precoz de pterigión e hipoacusia con derivación oportuna al especialista.
- Seguimiento y repetición de audiometrías en los casos presuntivos de hipoacusia.

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

- Evaluaciones ergonómicas del puesto de trabajo, especialmente en tareas repetitivas.
- Capacitación en postura correcta, estiramientos y cuidado visual y auditivo.

6. Salud mental y bienestar emocional

- Promover espacios para la gestión del estrés (charlas, pausas para relajación).
- Crear o fortalecer canales de apoyo psicológico o consejería, internos o externos.
- Fomentar el equilibrio entre vida laboral y personal con medidas de flexibilidad, si es posible.

7. Educación y participación del trabajador

- Desarrollar una cartelera o boletín de salud mensual, con información accesible y útil.
- Involucrar a los trabajadores en la planificación de actividades de promoción de la salud para mejorar la participación.

Estas medidas permitirán reducir la incidencia de patologías metabólicas y mejorar el estado general de salud del personal, en concordancia con el **Decreto Ejecutivo 255** y el **Acuerdo Ministerial MDT-2024-196**, vigentes en Ecuador.

Atentamente:

Dr. Rolando Maldonado
 Cl. 0103789756
**MAGISTER EN SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL
 Y SALUD OCUPACIONAL**
 Registro N° 1006-16-86073905